

단순 전립선 적출술은 소변 흐름을 막는 매우 큰 전립선비대증(BPH)을 치료하는 수술입니다. 집도의가 복부를 통해 전립선의 비대해진 내부 조직(선종)만 제거합니다. 개복 또는 로봇·복강경 방식으로 시행하며, 큰 전립선에 매우 효과적입니다.

중요한 차이점

“단순” 전립선 적출술은 전립선 **암**을 치료하는 “근치적” 전립선 적출술과 **다릅니다**. 근치적 수술은 암 치료를 위해 전립선 전체를 제거합니다. **단순** 전립선 적출술은 비대해진 내부 조직(양성)만 제거하고 외부 껍질은 남깁니다 — **암이 아닌 비대로 인한 폐색**을 치료합니다.

적응증

- 일반 내시경 수술(TURP)이 적합하지 않은 **매우 큰 전립선**
- 특히 **방광 결석**이나 큰 방광 게실이 동반된 경우
- 큰 전립선에 대한 내시경 대안(**HoLEP, Aquablation**)도 있으며 — 어떤 방법이 적합한지는 담당 의사와 상담하세요

용어 설명

단순 전립선 적출술

BPH 치료를 위해 전립선 내부 비대 조직을 제거하는 수술(암 수술 아님).

선종(Adenoma)

제거되는 양성 전립선 내부 조직.

근치적 전립선 적출술

암 치료를 위해 전립선 전체를 제거하는 별도의 수술.

개복 vs. 로봇

하나의 절개 또는 소형 복강경 절개로 진행.

역행성 사정

건식 오르가즘 — 흔한 후유증.

도뇨관(Catheter)

수술 후 며칠간 방광을 배액하는 관.

아픈가요? 전신마취 하에 시행되므로 수술 중 통증은 없습니다. 복부 수술이기 때문에 회복 기간이 **내시경 수술보다 길니다** — 며칠간 입원(로봇 수술 시 더 짧음), 며칠간 도뇨관 유지, 수 주간 활동 제한이 예상됩니다.

준비 방법

- **전신마취**로 진행 — 금식 및 약물 지침을 따르세요(혈액희석제는 지시에 따라 중단).
- 수술 전 감염 여부 확인을 위한 **소변 검사**.
- 금연하고 귀가 도움 및 가정 내 보조자를 준비하세요.

진행 과정 & 수술 후

- 1 마취 후 항생제를 투여합니다.
- 2 개복 또는 로봇·복강경 접근으로 비대해진 전립선 내부만 제거하고 외부 껍질은 남깁니다.
- 3 도뇨관(때로는 배액관)을 유치하며, 입원 기간은 수일(로봇 수술 시 더 짧음).
- 4 도뇨관은 보통 **며칠에서 약 1주일**간 유지됩니다.

초기에는 혈뇨가 나올 수 있습니다. 수 주간 **무거운 물건 들기와 힘주기를 피하세요**.

수술 후 예상 사항

- 소변 흐름이 강하고 지속적으로 개선됩니다.
- **역행성 사정**(건식 오르가즘)은 흔합니다. 발기 또는 요자제력에 심각한 영향은 드뭅니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관 제거 후 **소변을 볼 수 없는 경우**
- **심한 출혈이나 혈괴**, 또는 발열·오한
- 복통 악화, 또는 상처 부위 발적·분비물
- 흉통, 호흡 곤란, 또는 다리 붓기·통증(응급)

기억할 세 가지

1. 단순 전립선 적출술은 매우 큰 BPH를 위해 내부 비대 조직만 제거합니다 — 전립선 전체를 제거하는 암 수술과 **다릅니다**.
2. 큰 전립선에 매우 효과적이며, 회복 기간이 내시경 수술(HoLEP/Aquablation)보다 길니다.
3. 역행성 사정과 도뇨관 유치(수일)를 예상하세요. 소변 불통, 심한 출혈, 발열 시 연락하세요.